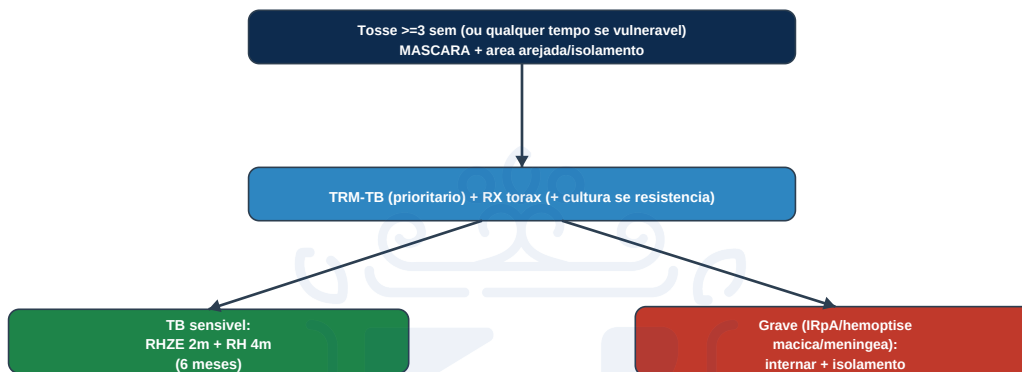


TUBERCULOSE — TRM-TB + RHZE 6 MESES

FLUXOGRAMA — IDENTIFICAR, ISOLAR, DIAGNOSTICAR

TB — SINTOMÁTICO RESPIRATÓRIO -> TRM-TB -> RHZE



DEFINIÇÃO E AVALIAÇÃO CLÍNICA

QUANDO SUSPEITAR

- Doença por *Mycobacterium tuberculosis*; pulmonar (transmissível) ou extrapulmonar; transmissão por aerossóis
- Sintomas: tosse PERSISTENTE (≥ 3 semanas, geralmente produtiva), febre vespertina, sudorese noturna, perda de peso, anorexia, fadiga, hemoptise
- Considerar TB em qualquer tosse $> 2-3$ semanas com sintomas sistêmicos ou fatores de risco
- RX típico (adulto imunocompetente): infiltrado em lobos SUPERIORES, cavitações, fibrose/retração; em criança/imunossuprimido: linfadenopatia hilar, infiltrados em lobos médios/inferiores, derrame
- Grupos de risco: PVHIV, privados de liberdade, diabéticos, etilistas/tabagistas, situação de rua, contatos domiciliares, indígenas

INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA

TRM-TB É PRIORITÁRIO

- TRM-TB (GeneXpert): exame de ESCOLHA — detecta DNA do *M. tuberculosis* e resistência à rifampicina em ~2h; mais sensível/específico que o BAAR
- Baciloscopia (BAAR): onde não há TRM-TB ou para controle mensal (sensibilidade 30-80%)
- CULTURA (padrão-ouro): suspeita de resistência, populações vulneráveis, ou exames rápidos negativos com suspeita persistente
- RX de tórax: triagem e avaliação de extensão; histopatológico nas formas extrapulmonares
- PVHIV: investigar TB independentemente do tempo de tosse; LF-LAM (urina) na imunossupressão grave; CRIANÇAS: diagnóstico clínico-radiológico por escore

ISOLAMENTO E PRECAUÇÕES

BIOSSEGURANÇA

- Transmissão por aerossóis (formas pulmonar e laríngea); identificar o sintomático respiratório na recepção
- Paciente: MÁSCARA CIRÚRGICA + área arejada/isolamento; profissional: máscara PFF2/N95
- Domiciliar: ambientes arejados, etiqueta de tosse; não é preciso separar utensílios; não isolar dos conviventes (já expostos), mas usar máscara se houver < 5 anos/idosos/imunocomprometidos
- Término do isolamento: ≥ 15 dias de tratamento + baciloscopia negativa (ambulatorial); hospitalar: 2 baciloscopias negativas após a 2ª semana (resposta clínica); TB resistente: cultura negativa
- CONTATOS: investigar (sintomáticos $\rightarrow$ TB; assintomáticos $\rightarrow$ PPD/IGRA + RX; PVHIV assintomáticos $\rightarrow$ tratar ILTB independente do PPD)

TRATAMENTO DA TB SENSÍVEL (RHZE)

Rx 6 MESES — 2RHZE + 4RH

Fase INTENSIVA (2 meses): Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol (RHZE), comprimido em dose fixa combinada

Fase de MANUTENÇÃO (4 meses): Rifampicina + Isoniazida (RH) — total de 6 meses

Dose por peso (RHZE 150/75/400/275): 20-35 kg = 2 comp; 36-50 kg = 3 comp; > 50 kg = 4 comp — pela manhã, em jejum (1h antes do café), longe de antiácidos/IBP

Exceções: TB meningocéfálica e osteoarticular $\rightarrow$ manutenção de 10 meses (total 12 meses), + corticoide na meníngea

TDO (tratamento diretamente observado) recomendado a todos, prioritário em TB resistente, situação de rua, vulnerabilidade, álcool/drogas

Notificação compulsória; acompanhamento mensal com baciloscopia de controle (cura: 2 baciloscopias negativas, uma nos últimos 2 meses)

SITUAÇÕES ESPECIAIS E EFEITOS ADVERSOS

Situação	Conduta-chave
PVHIV	Mesmo RHZE; dobrar dolutegravir (50 mg 12/12h) com rifampicina; iniciar TARV em até 7 dias (4-6 sem se TB meníngea)
Gestante/lactante	Mesmo esquema + PIRIDOXINA 50 mg/dia (previne neuropatia da isoniazida); amamentação permitida
Hepatotoxicidade	Suspender RHZE se TGO/TGP $\geq 5x$ (ou $\geq 3x$ com sintomas); reintroduzir após normalizar (R+E, depois H, depois Z)
Efeitos adversos	Isoniazida: neuropatia (piridoxina); Etambutol: neurite óptica; Rifampicina: urina/secreções alaranjadas, indutor do P450

CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO

QUANDO HOSPITALIZAR

- ☐ Insuficiência respiratória aguda
- ☐ Hemoptise maciça ou persistente (risco de asfixia)
- ☐ TB disseminada/miliar, meníngea ou outras extrapulmonares graves (alteração de consciência, déficit, sinais meníngeos)
- ☐ Intolerância medicamentosa incontrolável em regime ambulatorial; comorbidades descompensadas
- ☐ Vulnerabilidade social extrema (sem moradia/risco de abandono, sobretudo em retratamento/falência/resistência)

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos; TB pulmonar (suspeita/confirmada por TRM-TB com sensibilidade à rifampicina ____); tosse há ____; HIV ____.
- Gravidade: ____ (IRpA / hemoptise volumosa / TB meníngea / caquexia / intolerância); SpO2 ____, RX ____ (cavitação?).
- Isolamento respiratório (máscara cirúrgica no paciente, N95 na equipe); RHZE iniciado ____; suporte ____.
- Solicito internação por critério ____; notificação compulsória; investigar contatos.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o exame diagnóstico prioritário (de escolha) para tuberculose pulmonar?

- A) Baciloscopia (BAAR) isolada
- B) TRM-TB (teste rápido molecular / GeneXpert), que também detecta resistência à rifampicina
- C) Sorologia
- D) PPD
- E) Hemocultura

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o esquema padrão e a duração do tratamento da TB pulmonar sensível?

- A) RHZE por 12 meses contínuos
- B) 2 meses de RHZE (fase intensiva) + 4 meses de RH (manutenção) = 6 meses
- C) Apenas isoniazida por 9 meses
- D) Rifampicina isolada por 6 meses
- E) 3 meses de RH

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual medicação do esquema da TB está associada à neurite óptica?

- A) Rifampicina
- B) Etambutol
- C) Isoniazida
- D) Pirazinamida
- E) Estreptomicina

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Em gestante e em PVHIV em tratamento de TB, qual medida previne a neuropatia periférica pela isoniazida?

- A) Suspender a isoniazida
- B) Suplementar piridoxina (vitamina B6) 50 mg/dia
- C) Dobrar a rifampicina
- D) Usar corticoide
- E) Trocar por etambutol

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Quando suspender o RHZE por hepatotoxicidade?

- A) Qualquer elevação de transaminases
- B) TGO/TGP $\geq 5x$ o normal, ou $\geq 3x$ com sintomas (náusea, dor abdominal, icterícia)
- C) Apenas se houver icterícia profunda
- D) Nunca suspender
- E) Somente se bilirrubina > 30

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

O TRM-TB (teste rápido molecular/GeneXpert) é o exame prioritário: detecta o DNA do *M. tuberculosis* e a resistência à rifampicina em ~2h, com sensibilidade/especificidade superiores ao BAAR.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

O esquema padrão é 2 meses de RHZE (fase intensiva) + 4 meses de RH (manutenção), totalizando 6 meses; TB meníngea/ostearticular estende a manutenção para 10 meses (total 12).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O etambutol associa-se à neurite óptica (escotomas, perda visual); na suspeita, suspende-se e modifica-se o esquema. A isoniazida causa neuropatia periférica.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A piridoxina (vitamina B6) 50 mg/dia previne a neuropatia periférica induzida pela isoniazida, indicada em gestantes, PVHIV e diabéticos.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Suspende-se o RHZE quando TGO/TGP ≥ 5 x o limite normal, ou ≥ 3 x com sintomas (náusea, dor abdominal, icterícia), reintroduzindo após a normalização de forma sequencial.

SM24
Suporte ao Plantão Médico